



OFIDISMO: MASTERCLASS CLÍNICA

Guía Definitiva de Diagnóstico y Manejo de Mordeduras de Serpiente

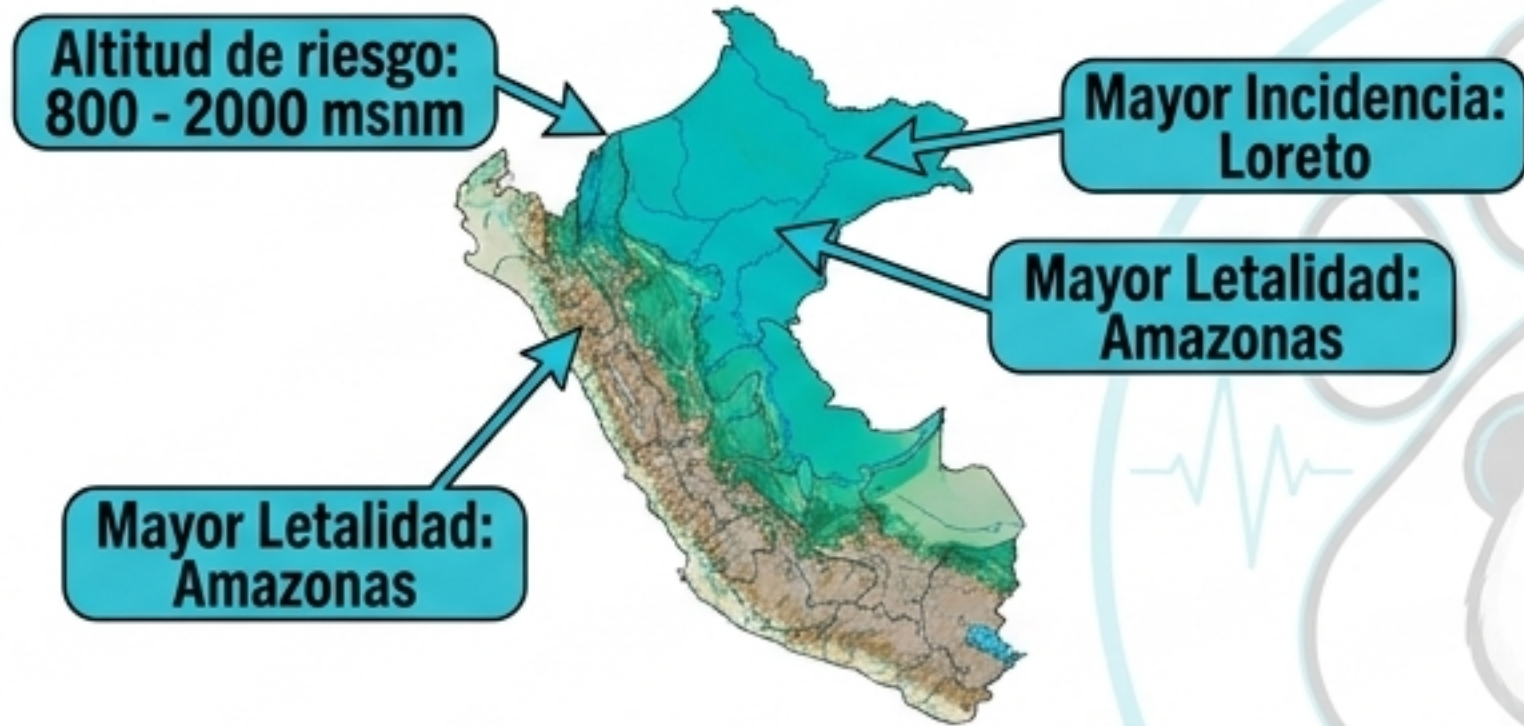
Definición Clínica: Conjunto de manifestaciones producidas por la inoculación accidental de veneno de serpientes (Viperidae, Elapidae, Hydrophiidae).

La gravedad clínica está determinada por:

1. Las características e inóculo del veneno.
2. La falta de tratamiento adecuado y oportuno. (El retraso produce secuelas graves o la muerte).

EPIDEMIOLOGÍA: EL MAPA DEL RIESGO EN PERÚ

Zona 1 (Geographía)



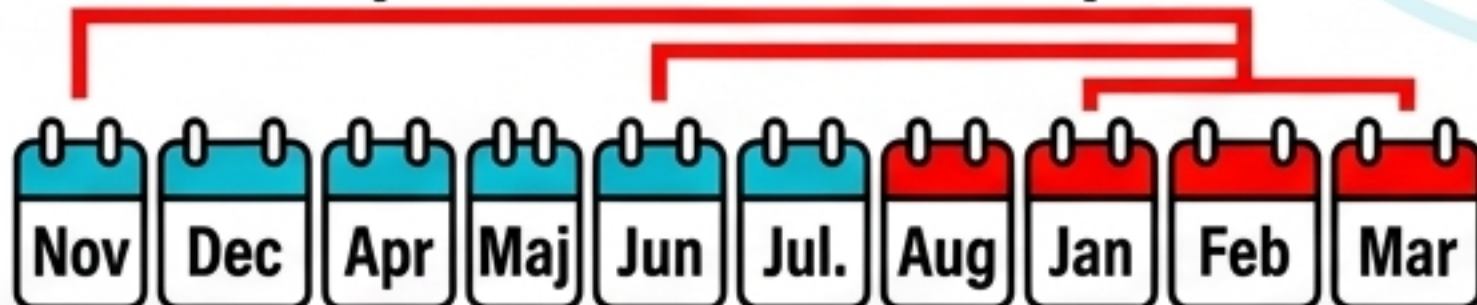
Zona 2: (El Paciente)



Grupo más afectado:
10 a 50 años (80%).
Predominio en varones
de zonas rurales.

Zona 3 (Tla Timeline)

**Temporada de Riesgo: Meses lluviosos
(Noviembre a Marzo).**



Zona 4 (Tla Especie)



**33 especies ponzoñasas
en Perú (9 oriundas).**

**El género Bothrops causa la inmensa
mayoría de los accidentes.**



DIAGNÓSTICO VISUAL: FAMILIA VIPERIDAE (Jergón, Cascabel, Shushupe)

Identificación rápida en el escenario prehospitalario.

Rasgo		VENENOSA	NO VENENOSA
Cabeza	 	Escamas pequeñas, forma triangular/corazón.	Escamas grandes/placas simétricas, forma variable.
Pupila & Foseta Loreal	 	Pupila vertical elíptica. PRESENCIA de foseta loreal (termorreceptora).	Pupila redonda. SIN foseta loreal.
Escamas & Cuerpo	 	Escamas carenadas (ásperas, opacas).	Escamas no carenadas (lisas, brillantes)
Actitud		Actitud de ataque (forma de 'S').	Tienden a escapar.

DIAGNÓSTICO VISUAL: FAMILIA ELAPIDAE (Corales)

Diferenciando las corales verdaderas (Naca naca) de las falsas.

VENENOSA (Corales Verdaderas)

NO VENENOSA (Falsas Corales)



Patrón de Anillos



Anillos **COMPLETOS** (dan la vuelta al vientre), formando triadas, a veces anillo rojo junto a otro rojo.



Anillos **INTERRUMPIDOS** en la parte ventral.



Cabeza y Ojos



Ojos pequeños. Cabeza alta y corta.



Ojos grandes. Cabeza chata y afilada.



Cola



Corta y gruesa.



Larga y delgada.



TAXONOMÍA Y DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Las principales amenazas ofídicas en territorio peruano.

VIPERIDAE

Genus	Nombre Popular	Distribución
<i>Bothrops / Bothriopsis / Porthidium</i>	Jergón, Macanche, Loro machaco, Yatutu.	(Selva alta/baja, Costa norte).
<i>Crotalus</i>	Cascabel.	(Sierra y selva alta).
<i>Lachesis</i>	Shushupe.	(Selva alta y baja).

ELAPIDAE

Genus	Nombre Popular	Distribución
<i>Micrurus / Leptomicrurus</i>	Naca naca, Chaquira, Culebra de 2 cabezas.	(Selva alta y baja).

HYDROPHIIDAE

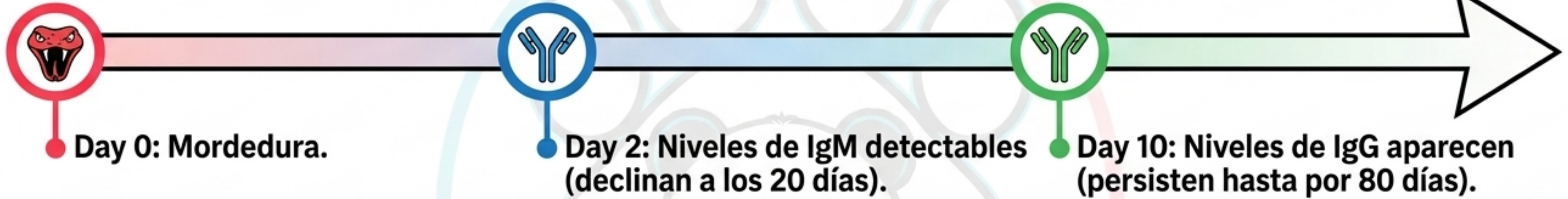
Genus	Nombre Popular	Distribución
<i>Pelamis</i>	Serpiente acuática.	(Mar de la costa norte).



MICROBIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA DEL BITE

La doble amenaza: Toxicidad y Sepsis Secundaria.

Inmunología Timeline



Flora Microbiana Dashboard



La mordedura introduce flora oral altamente patógena de la serpiente, complicando la recuperación.

Morganella morganii, • *Escherichia coli*, • *Providencia sp.* • *Streptococo grupo B* • *Enterobacter sp.* • *Clostridium sp.* • *Bacteroides sp.*



SÍNDROME BOTRÓPICO: ESCALA DE GRAVEDAD

Manifestaciones hemohistotóxicas (Especies: *Bothrops* sp.)

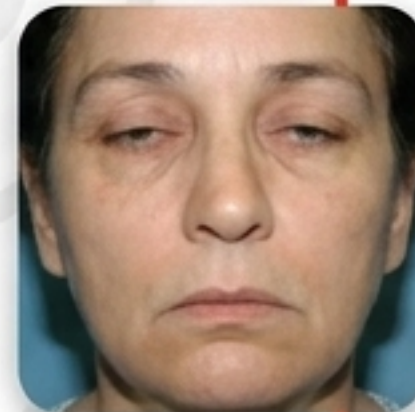
LEVE	MODERADA	GRAVE
• Local: Edema, eritema y dolor discreto. • Sistémico: Ausentes. • Labs: Tiempo de Coagulación (TC) normal o alterado.	• Local: Edema, eritema y dolor evidente. • Sistémico: Ausentes o hemorragias. • Labs: TC normal o alterado.	• Local: Intensas: equimosis, bulas, necrosis. • Sistémico: Hipotensión, shock, hemorragia grave, Insuficiencia Renal Aguda (IRA).  • Labs: TC normal o alterado. Pruebas de función renal alteradas.



SÍNDROME CROTÁLICO: ESCALA DE GRAVEDAD

Manifestaciones neurotóxicas y miotóxicas (Especie: *Crotalus durissus terrificus*)

LEVE	MODERADA	GRAVE
• Local: Ninguna o edema y parestesias discretos. • Sistémico: Fascies miasténica discreta. Mialgia discreta o ausente. • Labs: TC normal o alterado.	• Local: Ninguna o edema y parestesias discretos. • Sistémico: Fascies miasténica evidente. Mialgia. • Labs: TC normal o alterado.	• Local: Ninguna o edema y parestesias discretos. (Signos locales leves pese a la gravedad sistémica). • Sistémico: Fascies miasténica severa. Mialgia evidente. Oliguria o anuria. Insuficiencia respiratoria. • Labs: TC normal o alterado. Pruebas de función renal alteradas.



SÍNDROME ELAPÍDICO: ESCALA DE GRAVEDAD

Bloqueo neuromuscular agudo (Especie: *Micrurus* sp.)

LEVE

MODERADA

GRAVE

----- (El rápido inicio neurotóxico colapsa las ventanas clínicas leves/moderadas).

- **Local:** Ninguna ó dolor local y parestesias discretas.
- **Sistémico:** Fascies miasténica severa (bloqueo de pares craneales). Mialgia generalizada. Parálisis respiratoria inminente.
- **Labs:** ----- (El diagnóstico es eminentemente clínico; los laboratorios hematológicos suelen no estar alterados por el veneno).



EL PROTOCOLO DIAGNÓSTICO

Los 5 pilares para la confirmación del accidente ofídico.



BADBEAR.MED



PRIMEROS AUXILIOS: MITOS VS. EVIDENCIA

Intervenciones prehospitalarias que salvan vidas (y extremidades).

LO QUE NUNCA SE DEBE HACER

- ✗ NO realizar sangrías, cortes o succión.
- ✗ NO aplicar torniquetes (Agrava severamente la isquemia y necrosis).
- ✗ NO aplicar shock eléctrico.
- ✗ NO usar crioterapia o hielo local.

LO QUE SE DEBE HACER

- ✓ Reposo absoluto del paciente (disminuye la absorción linfática).
- ✓ Inmovilizar la extremidad afectada.
- ✓ Traslado INMEDIATO al establecimiento de salud más cercano.



MANEJO MÉDICO GENERAL

Estabilización intrahospitalaria **previa** y **paralela** a la **sueroterapia**.

Soporte Vital

- **Control** constante de funciones vitales y volumen urinario.
- **Hidratación** EV.
- **Transfusión** sanguínea si hay shock hemorrágico.

Cuidado Local

- Mantener el miembro afectado en alto.
- **Asepsia** estricta de la lesión.
- **Profilaxis antitetánica** obligatoria.

Farmacología

- **Analgésicos y ansiolíticos** (EVITAR depresores del SNC, especialmente en S. Crotálico/Elapídico).
- **Antibioticoterapia:** Amoxicilina/Ácido Clavulánico, Cloranfenicol (CAF) u otras asociaciones (para cubrir flora oral de la serpiente).
- **Dexametasona:** Uso reservado para profilaxis de hipersensibilidad o manejo de Síndrome Compartimental.



SUEROterapia ANTIOFÍDICA

El **único tratamiento definitivo y específico**. (Inmunoglobulinas F(ab')₂).

EL ARSENAL - Tipos de Suero en Perú

- | | |
|----|---|
| 1. | Polivalente (Líquido/Liofilizado) : Para género <i>Bothrops</i> (Jergón, cascabel de selva, macanche).
Nota : Liofilizado no requiere refrigeración. |
| 2. | Monovalente Anticrotálico : Para <i>Crotalus durissus terrificus</i> (Cascabel). |
| 3. | Monovalente Antilachésico : Para <i>Lachesis muta muta</i> (Shushupe). |

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN

Pruebas de sensibilidad /
Antihistamínicos previos.

Diluir la dosis total en 100-500 ml de
Cloruro de Sodio 0.9% o Dextrosa 5%.

Aplicación estrictamente EV. Inicio
con goteo lento, escalando velocidad.

Infusión total en **30 a 60 minutos.**
Debe aplicarse idealmente en la 1° hora del accidente.



COMPLICACIONES: SÍNDROME COMPARTIMENTAL

Reconocimiento clínico y manejo quirúrgico de salvataje.

Caso clínico:

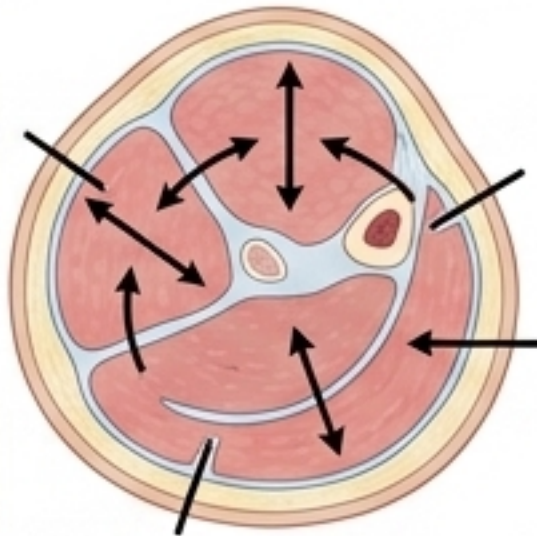
Niña de 10 años,
mordida por
Bothrops sp.

Timeline Phase 1 (Toxicidad)

- Edema progresivo, dolor intenso, hiperestesias.

Timeline Phase 2 (Compromiso Vascular)

- Pérdida de pulsos tibiales, cambios isquémicos (palidez/frialdad), sepsis e isquemia muscular progresiva.



- El síndrome compartimental es indicativo absoluto de manejo quirúrgico.
- **Procedimientos:** Fasciotomía lateral ampliada + Debridación quirúrgica.
- **Cierre:** Terapia de presión negativa (VAC) durante semanas -> contracción de herida -> **injertos** cutáneos.



CONCLUSIONES Y REGLAS DE ORO

Resumen clínico para la práctica médica y prevención en comunidad.



Regla 1 (El Tiempo es Tejido): El tratamiento oportuno y adecuado es el único pilar para evitar muertes y secuelas.



Regla 2 (No hay caducidad para la vida): La administración del suero antiponzoñoso **debe aplicarse** incluso si ha transcurrido un tiempo prolongado desde el accidente (el veneno sigue circulando/fijándose).



Regla 3 (Neurotoxinas vs Hemotoxinas): Los venenos neurotóxicos (Crotalus, Micrurus) **exigen tratamientos** aún más precoces que los hemohistotóxicos (Bothrops) para neutralizar las toxinas antes de que se fijen irreversiblemente a los receptores.



Regla 4 (El Quirófano): El Síndrome Compartimental ofídico no se observa, se opera (Fasciotomía).



Prevención en el Campo:

- No caminar descalzo.
- No introducir manos en huecos de árboles o piedras.
- Usar botas en vegetación/oscuridad.
- Construir casas sobre altillos.



BADBEAR.MED | Facebook • Instagram • YouTube • Rutube • OnlyFans • Telegram • TikTok